



PROTOCOLO — PRONTO-SOCORRO NATAL DIEGUES

Prefeitura Municipal de Estiva Gerbi / SP • Secretaria Municipal de Saúde

Série de protocolos institucionais de urgência e emergência — uso interno da equipe médica

Protocolo 36 — Abordagem da Dor Aguda no Pronto-Socorro: avaliação, analgesia multimodal, opioides com segurança, dor em populações especiais e dor crônica agudizada

Escala e reavaliação obrigatórias, escada analgésica invertida para a emergência, doses e vias, sedação/analgesia para procedimentos, opioide sem excesso e sem negação, dor crônica/oncológica/paliativa — prevenção quaternária

Código	PS-ND-36	Versão	1.0 (minuta)
Elaboração	Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986	Data-base	setembro/2026
Aprovação (Diretor Clínico)	_____	Vigência	___/___/___
Aprovação (Coordenação PS)	_____	Revisão prevista	___/___/___

0. Escopo, premissas e fontes

Dor é a queixa mais frequente do PS (60-80% dos atendimentos) e é **subtratada** (oligoanalgesia: espera longa, doses baixas, medo de "mascarar", preconceito com idosos, crianças, usuários de drogas, pessoas negras, dor crônica) e, ao mesmo tempo, tratada com **excesso de opioide e de injeção** em quem não precisa. Este protocolo transversal define: dor medida e reavaliada como sinal vital, analgesia iniciada na triagem por protocolo de enfermagem, escolha por tipo e intensidade de dor (multimodal), opioide quando indicado — na dose certa, pela via certa, com plano — e o que não fazer. É P4 aplicada: aliviar sem iatrogenia.

Fontes de ancoragem: Motov S, et al. The treatment of acute pain in the emergency department: a white paper position statement prepared for the American Academy of Emergency Medicine (AAEM). J Emerg Med 2018;54:731 [AAEM 2018]; American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues related to opioids in adult patients presenting to the ED. Ann Emerg Med 2020;76:e13 [ACEP 2020]; **Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED). Diretrizes/recomendações para dor aguda** (edição vigente) [SBED — VERIFICAR]; Ministério da Saúde. PCDT Dor crônica (Portaria 1.083/2012) e Portaria 344/1998 (controle de opioides) [MS]; WHO. Guidelines on the management of chronic pain in children (2020) e cancer pain (2018) [OMS]; Chou R, et al. Management of postoperative pain (APS/ASA). J Pain 2016;17:131; Godwin SA, et al. ACEP clinical policy: procedural sedation and analgesia. Ann Emerg Med 2014;63:247 [ACEP-PSA]; Green SM, et al. Ketamine for procedural sedation (ACEP 2011); Manterola C, et al. Cochrane 2011 (analgesia no abdome agudo); ANCP — Manual de cuidados paliativos (2023); Protocolos 20, 21, 33, 34 desta série.

Convenção de confiança: doses conforme AAEM 2018/ACEP 2020/SBED; pediátricas sob dose lock; **[VERIFICAR]:** dipirona IV, cetorolaco, morfina/fentanil (controle Portaria 344), cetamina, lidocaína, naloxona, bombas, oximetria/capnografia para sedação, protocolo de enfermagem para analgesia na triagem (aprovação institucional).

1. Avaliar — a dor como sinal vital

Item	Conduta
Medir na triagem	Escala numérica 0-10 (adulto/>8 anos); faces (Wong-Baker) 3-8 anos; FLACC (<3 anos/não verbal: face, pernas, atividade, choro, consolabilidade); PAINAD (demência); registrar junto com FC/PA/FR/T/SpO ₂
Caracterizar (5 min)	Início, localização/irradiação, tipo (nociceptiva somática — localizada, pontada; visceral — difusa, cólica, referida; neuropática — queimação, choque, formigamento, alodinia; mista), intensidade, fatores de melhora/piora, o que já usou, dor crônica de base e seu tratamento, uso de opioide (tolerância), alergias, função renal/hepática, gestação
Intensidade → alvo	Leve 1-3 • moderada 4-6 • intensa 7-10; alvo: redução ≥50% ou ≤3-4/10 e função (conforto, mobilidade), definido com o paciente — não "zero" a qualquer custo
Reavaliar	30 min após analgesia IV/IM (60 min VO); a cada 1-2 h; antes da alta — registrar a nova pontuação ; dor que não melhora ou muda = reavaliar o diagnóstico, não só a dose
Diagnóstico primeiro?	Não : analgesia não mascara abdome agudo, apendicite, peritonite nem TCE (Cochrane 2011); tratar a dor enquanto se investiga; a exceção é sedar antes de examinar o sensório
Grupos com risco de oligoanalgesia	Idosos, crianças, demência, pessoas negras, mulheres com dor abdominal/pélvica, usuários de drogas, dor crônica, não falantes do português, pessoas em situação de rua — medir e tratar igual

2. Princípios — escada invertida, multimodal e via certa

2.1 Escolha pela intensidade e tipo (escada analgésica "invertida" da emergência: começar no degrau correspondente à dor)

Dor	1ª escolha (multimodal)	Se insuficiente em 30-60 min	Evitar
Leve (1-3) nociceptiva	Dipirona 1 g VO/IV ou paracetamol 750-1.000 mg VO ± AINE VO (ibuprofeno 400-600 mg) + medidas físicas (calor/frio, imobilização, posição)	Associar o outro não opioide	Opioide; injeção IM "para fazer efeito rápido"
Moderada (4-6)	Dipirona 1-2 g IV + AINE (cetorolaco 15-30 mg IV; cetoprofeno 100 mg IV) ; cólica: + escopolamina; neuropática: + gabapentinoide/lidocaína; procedimento: anestesia local/bloqueio	Tramadol 50-100 mg IV/VO (menos eficaz, náusea, convulsão/serotoninérgica) ou morfina 2-4 mg IV titulada	Codeína (metabolismo imprevisível), meperidina, injeção IM de rotina
Intensa (7-10)	Morfina 0,05-0,1 mg/kg IV (3-5 mg) a cada 10-15 min até alvo ou fentanil 1 mcg/kg IV (rápido, curto — ideal para procedimento/instável) + dipirona/AINE (poupador) + adjuvantes por tipo (cetamina 0,1-0,3 mg/kg em dose analgésica; bloqueio regional; lidocaína IV na cólica renal/neuropática)	Repetir morfina/fentanil titulando; cetamina em dose analgésica; bloqueio; reavaliar diagnóstico	Dose única "e espera"; IM; benzodiazepínico como "analgésico"; opioide sem antiemético/monitorização
Cólica (renal, biliar)	AINE IV primeiro (cetorolaco 30 mg / diclofenaco 75 mg IM) + dipirona (Protocolo 21)	Morfina	Hiper-hidratação; escopolamina isolada
Neuropática aguda (zóster, radiculopatia, neuropatia)	Gabapentina 300 mg → 900-1.800 mg/dia (ou pregabalina 75 mg); amitriptilina 25 mg à noite; lidocaína tópica; AINE/dipirona para o componente nociceptivo	Tramadol (efeito serotoninérgico útil); cetamina; bloqueio	Opioide forte como 1ª linha
Dor crônica agudizada	Manter o esquema de base; tratar o gatilho; não opioide multimodal; contato com quem acompanha	Resgate opioide breve se já usa (ajustar por tolerância); plano de alta com o serviço de origem	Iniciar opioide crônico no PS; "injeção de rotina" a cada visita
Oncológica / paliativa	Morfina IV titulada (sem teto; usuário crônico: 10-20% da dose diária como resgate); tratar causa (fratura, obstrução, compressão medular — dexametasona); adjuvantes	Rotação/ajuste com a equipe de paliativos	Negar opioide por "risco de dependência"; naloxona por sonolência esperada

2.2 Regras de segurança do opioide no PS [ACEP 2020; AAEM 2018]

- **Indicação clara** (dor intensa nociceptiva, fratura, queimadura, IAM, oncológica, cólica refratária) e **via IV titulada** em doses pequenas repetidas (morfina 2–4 mg a cada 10–15 min; fentanil 25–50 mcg a cada 5–10 min) — não IM (absorção errática, dor, sem titulação); VO (morfina 5–10 mg, oxicodona) se via oral possível.
- **Monitorar:** FR, SpO₂, sedação (Pasero/RASS) a cada 15–30 min após cada dose; **naloxona à mão** (0,04–0,1 mg IV titulada para reverter depressão respiratória sem retirar toda a analgesia); reduzir dose em idoso (metade), DRC (morfina acumula metabólito — preferir fentanil/hidromorfona), hepatopatia, DPOC/apneia do sono, uso concomitante de BZD/álcool.
- **Antiemético** (ondansetrona 4 mg / metoclopramida 10 mg) se náusea; laxante se >2–3 dias; prurido: anti-H1 em dose baixa.
- **Na alta:** opioide só se dor intensa com causa definida (fratura, pós-operatório, queimadura) — **menor dose, ≤3–5 dias** (tramadol 50–100 mg 6/6 h ou codeína 30 mg + paracetamol; morfina VO em oncológico), receita B (Portaria 344), orientação escrita (sedação, não dirigir, não combinar com álcool/BZD, guardar trancado, descarte), **sempre associado a não opioide**, retorno definido; nunca "renovar" opioide de dor crônica no PS sem contato com o prescritor.
- **Não usar:** meperidina (neurotoxicidade), codeína em crianças/<12 anos e lactantes (metabolismo ultrarrápido), tramadol em epilepsia/ISRS/<12 anos, opioide + benzodiazepínico (depressão respiratória) fora de sedação monitorada.
- **Pessoa com transtorno por uso de opioide/em tratamento (metadona/buprenorfina):** tem dor real e tolerância — manter o tratamento de base e usar doses maiores tituladas; não estigmatizar; usuário de drogas ilícitas: mesma analgesia, mais vigilância.

2.3 O que não fazer (eventos sentinela desta série)

- Negar analgesia "para não mascarar" (abdome, TCE, fratura); esperar exames para analgesiar; "dipirona + esperar o médico" por horas na fila.
- Injeção IM de rotina (dipirona/diclofenaco/opioide IM) quando VO ou IV titulada são possíveis — dor, abscesso, lesão de nervo, absorção errática; diclofenaco IM: necrose glútea (Nicolau).
- Benzodiazepínico como analgésico; opioide + BZD sem monitor; meperidina; codeína em criança; AINE em DRC/IC/úlcera/gestante 3º trimestre/idoso desidratado; dipirona sem perguntar alergia/agranulocitose prévia.
- Alta com opioide sem plano/duração; renovar receita de opioide crônico no PS; dispensar "kit" de injeções para dor crônica sem reavaliação diagnóstica.

3. Fármacos — doses, vias e cautelas [AAEM 2018; SBED; bulas]

3.1 Não opioides

Fármaco	Adulto	Criança (dose lock)	Cautelas
Dipirona	1–2 g IV lento (diluída, 5–10 min) ou VO 500 mg–1 g 6/6 h (máx. 4–6 g/dia)	15 mg/kg/dose 6/6 h (VO/IV) — evitar <3 meses	Hipotensão se IV rápida; agranulocitose (rara); alergia; não em gestante 3º trimestre
Paracetamol	750–1.000 mg VO 6/6 h (máx. 3–4 g; 2–3 g em hepatopata/etilista)	10–15 mg/kg/dose 6/6 h (máx. 75 mg/kg/dia)	Hepatotoxicidade em dose alta; sem IV no SUS habitual
Ibuprofeno	400–600 mg VO 8/8 h (máx. 2,4 g)	5–10 mg/kg/dose 6/6–8/8 h (>6 meses)	AINE: DRC, IC, úlcera/sangramento, anticoagulante, gestante 3º trimestre, asma sensível, idoso (menor dose, IBP, ≤5 dias)
Cetorolaco	30 mg IV/IM (15 mg >65 a/<50 kg/DRC leve); máx. 5 dias	0,5 mg/kg IV (máx. 15–30 mg) >2 anos	Idem AINE; IV é tão eficaz quanto 30 mg e 15 mg = 30 mg
Cetoprofeno / diclofenaco / naproxeno	Cetoprofeno 100 mg IV em 100 mL (20 min) ou VO 50 mg 8/8 h; diclofenaco 50 mg VO 8/8 h (IM 75 mg só em cólica se cetorolaco indisponível); naproxeno 500 mg 12/12 h	Naproxeno 5–7 mg/kg 12/12 h (>2 anos)	Idem; diclofenaco IM: risco de necrose (Nicolau) — preferir IV/VO
Anestesia local / bloqueios	Lidocaína 1–2% (máx. 4,5 mg/kg; 7 mg/kg com adrenalina); bupivacaína 0,25–0,5% (máx. 2–2,5 mg/kg); bloqueios (femoral/fáscia ilíaca para fêmur; hematoma para punho; digital; occipital; serrátil) se treinado	Lidocaína 1% — máx. 4,5 mg/kg; EMLA/lidocaína tópica para punções	Toxicidade sistêmica (emulsão lipídica); sem adrenalina em extremidades (controverso — aceitável em dedos hoje); aspirar antes
Cetamina em dose analgésica	0,1–0,3 mg/kg IV lento (10–15 min, diluída) ou 0,5–1 mg/kg IN; infusão 0,1–0,3 mg/kg/h	0,1–0,3 mg/kg IV; 0,5–1 mg/kg IN	Poupa opioide; disforia leve (reduzir velocidade); evitar em psicose ativa/HIC descontrolada (hoje aceitável em TCE)
Lidocaína IV	1–1,5 mg/kg em 10–20 min (máx. 100–150 mg)	—	Cólica renal, neuropática, refratária — com monitor
Escopolamina (hioscina)	20 mg IV/VO 8/8 h	0,5 mg/kg	Cólica visceral; efeito modesto; taquicardia; não em íleo
Gabapentina / pregabalina / amitriptilina / duloxetina	Gabapentina 300 mg → 900–1.800 mg/dia; pregabalina 75–150 mg 12/12 h; amitriptilina 12,5–25 mg à noite; duloxetina 30–60 mg	Gabapentina 5–10 mg/kg/dia (>3 anos) — especialista	Neuropática; sedação, tontura; ajuste renal; efeito em dias — iniciar no PS com seguimento
Dexametasona	4–10 mg IV/VO	0,15–0,6 mg/kg	Adjuvante: migrânea (recorrência), compressão medular/óssea oncológica, dor de garganta intensa; não para dor inespecífica
Medidas não farmacológicas	Imobilização/tala, elevação, calor (musculoesquelética/cólica) ou frio (trauma agudo 48 h), posição de conforto, informação/tranquilização, distração (criança), respiração, ambiente calmo	Sacarose 24% oral (lactente), amamentação, contato pele a pele, distração	Sempre — reduzem dose de fármaco

3.2 Opioides

Fármaco	Adulto	Criança (dose lock)	Observações
Morfina (1ª escolha para dor intensa)	0,05-0,1 mg/kg IV (2-5 mg) lento a cada 10-15 min até alvo; manutenção 2-5 mg a cada 3-4 h; VO 5-10 mg 4/4 h (biodisponibilidade 30%)	0,05-0,1 mg/kg IV (máx. 2-4 mg/dose); VO 0,2-0,3 mg/kg	Início 5-10 min IV, pico 20 min, duração 3-4 h; metabólito ativo acumula em DRC; liberação de histamina (prurido, hipotensão em hipovolêmico); antiemético
Fentanil	1 mcg/kg IV (50-100 mcg) a cada 5-10 min; IN 1,5-2 mcg/kg (sem acesso — criança/adulto)	1-1,5 mcg/kg IV; IN 1,5-2 mcg/kg	Início 1-2 min, duração 30-60 min; sem histamina (preferir em instável/asma/DRC); rigidez torácica em bólus rápido de dose alta
Tramadol	50-100 mg VO/IV lento (diluído em 100 mL, 20 min) 6/6 h (máx. 400 mg/dia; 200 mg >75 a/DRC)	1-2 mg/kg (>12 anos)	Fraco; náusea/vômito; convulsão (epilepsia, dose alta), serotoninérgica (ISRS, tramadol + ondansetrona reduz efeito); não <12 anos
Codeína	30-60 mg VO 4/4-6/6 h (+ paracetamol)	Não usar <12 anos	Pró-fármaco (10% não metabolizam; ultrarrápidos intoxicam); constipação
Oxycodona	5-10 mg VO 4/4-6/6 h (não no SUS habitual)	—	Alta liberação; receita A
Metadona / buprenorfina	Manter o esquema do paciente em tratamento; não iniciar no PS	—	Paliativos/dependência — especialista
Naloxona	0,04-0,1 mg IV a cada 2-3 min (reverter depressão respiratória preservando analgesia); 0,4-2 mg se PCR/coma; IM/IN 0,4-2 mg	0,01 mg/kg (0,1 mg/kg em intoxicação)	Meia-vida 30-90 min (< opioide): observar/repetir; abstinência aguda se dose alta em dependente

3.3 Sedação e analgesia para procedimentos (redução de fratura/luxação, drenagem, sutura extensa, cardioversão) [ACEP-PSA 2014]

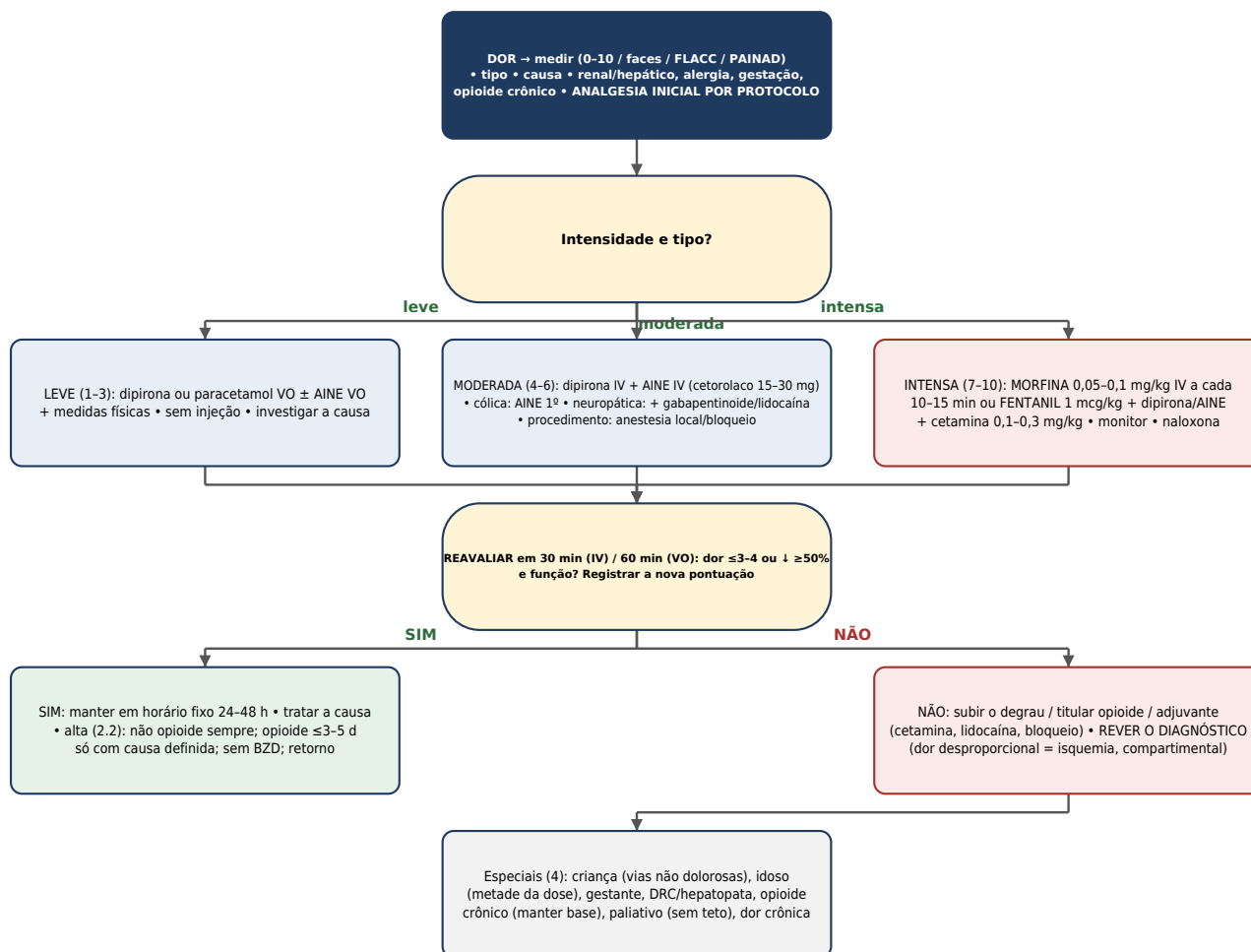
Item	Conduta
Pré-requisitos	Avaliação (ASA, via aérea — Mallampati, jejum — não obrigatório para procedimento urgente; risco de aspiração), consentimento, monitor (ECG, SpO₂, PA), capnografia se disponível, O₂, aspirador, BVM, material de via aérea e antídotos (naloxona, flumazenil) à mão, profissional dedicado à sedação além do que faz o procedimento , registro de sinais vitais a cada 5 min; alta só após retorno ao basal (Aldrete/sem sedação) com acompanhante
Cetamina (dissociativa — 1ª escolha em criança e em procedimento doloroso)	1-1,5 mg/kg IV em 1 min (repetir 0,5 mg/kg) ou 4-5 mg/kg IM ; adulto: 0,5-1 mg/kg IV; preserva reflexos e ventilação; contraindicações relativas: <3 meses, psicose, HIC descontrolada; efeitos: sialorreia, laringoespasma (raro — BVM/CPAP), emergência (ambiente calmo; midazolam 0,03 mg/kg se agitação em adulto); não usar BZD profilático de rotina
Cetamina + propofol ("ketofol")	Cetamina 0,5 mg/kg + propofol 0,5 mg/kg IV, repetir metade — adulto; menos hipotensão/apneia que cada um isolado
Propofol	0,5-1 mg/kg IV + 0,25-0,5 mg/kg a cada 1-3 min — sedação profunda curta (cardioversão, luxação); hipotensão/apneia — só com capnografia e via aérea pronta; não é analgésico (associar fentanil 0,5-1 mcg/kg)
Midazolam + fentanil	Midazolam 0,02-0,05 mg/kg IV (1-2 mg) + fentanil 0,5-1 mcg/kg, titulados; mais depressão respiratória que cetamina; flumazenil/naloxona à mão
Etomidato	0,1-0,2 mg/kg IV — hemodinamicamente estável (cardioversão, luxação em cardiopata); mioclonias; sem analgesia
Óxido nítrico / sedação leve	N ₂ O 50% se disponível (criança, sutura); midazolam VO 0,5 mg/kg (máx. 15 mg) 20-30 min antes; IN 0,2-0,3 mg/kg
Bloqueio regional em vez de sedação	Fratura de fêmur/quadril: bloqueio de fáscia ilíaca (bupivacaína 0,25% 20-30 mL); punho (bloqueio de hematoma com lidocaína 1% 10 mL); dedos (bloqueio digital); ombro (intra-articular) — reduz opioide e sedação, ideal em idoso

4. Populações e situações especiais

Situação	Conduta
Criança	Medir (FLACC/faces); analgesia na triagem por protocolo (dipirona/ibuprofeno VO; fentanil IN 1,5 mcg/kg para fratura); vias não dolorosas (VO/IN/tópica) preferidas; EMLA/lidocaína para punção; sacarose/amamentação em lactente; distração; cetamina para procedimentos; sem codeína/tramadol <12 anos ; pais presentes
Idoso	Dor subtratada (PAINAD em demência); paracetamol/dipirona base; AINE com cautela (≤ 5 dias, IBP, sem DRC/IC); opioide em metade da dose titulada; evitar anticolinérgicos/BZD (delirium, queda); bloqueios regionais em fratura de quadril
Gestante	Paracetamol/dipirona (evitar dipirona no 3º trimestre — fechamento ductal controverso; AINE contraindicado após 30 semanas); opioide em dor intensa (morfina/fentanil ok; evitar uso crônico); tramadol/codeína com cautela; lidocaína para bloqueios; evitar cetamina na pré-eclâmpsia
DRC	Evitar AINE; dipirona/paracetamol; opioide: fentanil ou hidromorfona (morfina/tramadol/codeína acumulam); gabapentinoide ajustado
Hepatopatia	Paracetamol ≤ 2 g/dia; evitar AINE (sangramento/LRA); opioide em dose reduzida; sem tramadol
Uso de opioide crônico / transtorno por uso	Manter dose de base + resgate 10–20% da dose diária; tolerância = doses maiores tituladas com monitor; não julgar; cetamina/bloqueio/AINE poupadores; em tratamento com metadona/buprenorfina: manter e adicionar analgesia (buprenorfina: dividir a dose ou adicionar opioide de alta afinidade); CAPS AD/SAE para seguimento
Dor crônica não oncológica agudizada (lombar, fibromialgia, cefaleia crônica, artrose)	Perguntar o que mudou; tratar o gatilho; manter o esquema de base; não opioide multimodal + não farmacológico; evitar opioide/injeção de rotina; contato com a APS/serviço de dor; se necessário, resgate curto (≤ 3 dias) documentado; retorno para revisão do plano — o PS não é o lugar de tratar dor crônica
Dor oncológica / cuidados paliativos	Titular morfina IV sem teto até conforto (usuário: dose de resgate = 10–20% da dose diária); tratar causa reversível (fratura, obstrução, compressão medular, hipercalcemia); adjuvantes (dexametasona, gabapentinoide, antiespasmódico, bisfosfonato na referência); náusea/constipação; dispneia (morfina em dose baixa); comunicação com paciente/família sobre metas; não usar naloxona por sonolência esperada; alta com morfina VO/SC e plano (equipe de paliativos/APS); nunca negar opioide por "risco de dependência"
Dor torácica / abdominal em investigação	Analgesia titulada não altera acurácia (Protocolos 01, 20); registrar resposta
Fratura / trauma	Analgesia antes de imobilizar/radiografar; imobilização é analgesia; bloqueio regional; fentanil IN se sem acesso (Protocolo 34)
Queimadura	Opioide IV titulado + cetamina para curativo (Protocolo 28)
Cólica renal / biliar	AINE IV 1ª linha (Protocolo 21/20)
Cefaleia	Sem opioide; antiemético dopaminérgico + dipirona/AINE $\pm$ triptano (Protocolo 32)
Lombalgia	AINE/dipirona, atividade, sem opioide/BZD (Protocolo 33)
Procedimentos menores (sutura, retirada de corpo estranho, punção)	Anestesia tópica (lidocaína/prilocaína — EMLA 60 min; lidocaína spray), infiltração com agulha fina e lidocaína tamponada/aquecida, bloqueio digital; distração; nunca "segurar e fazer"

6. Fluxo de atendimento [AAEM 2018; ACEP 2020, adaptado]

Medir → tratar na triagem pelo degrau certo → reavaliar em 30-60 min e registrar → subir o degrau ou rever o diagnóstico → alta com plano. A dor que não responde ao esperado é um sinal, não uma falha de dose.



■ Entrada ■ Decisão ■ Conduta ■ Risco / atenção ■ Desfecho / transferência

6.1 Metas de tempo

Intervalo	Meta
Triagem → escala de dor registrada	100% na triagem
Dor moderada/intensa → 1ª analgesia	≤20-30 min da chegada (protocolo de enfermagem para dipirona/ibuprofeno/analgesia na triagem [VERIFICAR aprovação]); dor intensa: médico em ≤15 min para opioide IV
Reavaliação após analgesia	30 min (IV/IM) / 60 min (VO) — registrada
Fratura/luxação → analgesia e imobilização	Antes do RX
Sedação para procedimento → alta	Retorno ao basal (≥30-60 min após última dose), acompanhante, orientação escrita

8. Organização, alta e indicadores

8.1 Protocolo de analgesia na triagem (proposta para aprovação institucional — enfermagem)

Condição	Enfermagem pode administrar (após checar alergia, gestação, DRC/úlcera, medicações)	Aciona médico imediatamente
Dor leve/moderada (≤ 6) sem sinais de gravidade, adulto	Dipirona 1 g VO (ou paracetamol 750 mg) $\pm$ ibuprofeno 400 mg VO; calor/frio; imobilização	Se sem melhora em 60 min
Criança >3 meses com dor leve/moderada	Dipirona 15 mg/kg VO ou paracetamol 15 mg/kg; ibuprofeno 10 mg/kg (>6 meses)	—
Dor intensa (≥ 7), fratura evidente, queimadura, trauma	Imobilizar, elevar, frio; preparar acesso; fentanil IN 1,5 mcg/kg se protocolo aprovado	Médico em ≤ 15 min para opioide IV/bloqueio
Cólica renal típica sem febre/idoso	Cetorolaco 30 mg IV/diclofenaco 75 mg IM (se protocolo) + dipirona	Médico para avaliação e USG
Dor torácica, abdominal com red flags, cefaleia súbita, sinais vitais alterados	Nada além de medidas gerais	Médico imediato (protocolos específicos)

8.2 Alta — o que escrever

- Diagnóstico/hipótese e o que foi feito (fármacos, doses, resposta em escala); analgesia de alta em **horário fixo nas primeiras 24-48 h** (não "se dor"), com nome, dose, intervalo, duração e dose máxima diária; não opioide sempre; AINE $\leq 5-7$ dias com proteção quando indicada; opioide $\leq 3-5$ dias só com indicação, receita controlada e orientações de segurança; medidas não farmacológicas.
- Sinais de alarme específicos da causa e retorno; contato da UBS/serviço que acompanha; para dor crônica: carta ao prescritor/APS informando o atendimento e que não houve renovação de opioide.
- Registrar a escala na alta (meta atingida?) e a recusa de analgesia quando ocorrer (e o motivo).

8.3 O que o PS precisa ter

- Escalas impressas/na triagem (numérica, faces, FLACC, PAINAD); protocolo de analgesia de enfermagem aprovado e treinado.
- Estoque: dipirona VO/IV, paracetamol (VO; gotas), ibuprofeno (VO; suspensão), cetorolaco IV, cetoprofeno IV, naproxeno, escopolamina, lidocaína 1-2% (com/sem vasoconstritor), bupivacaína, EMLA/lidocaína tópica, gabapentina, amitriptilina, morfina (10 mg/mL) e fentanil (50 mcg/mL) com controle (Portaria 344 — livro/receituário), tramadol, naloxona (≥ 10 ampolas), cetamina, midazolam, propofol, ondansetrona, metoclopramida, sacarose 24%; bombas de infusão; monitor com capnografia para sedação; dispositivo de atomização nasal (MAD) para fentanil/cetamina/midazolam IN [VERIFICAR].
- Treinamento em bloqueios básicos (fáscia ilíaca, hematoma, digital, occipital) e em sedação para procedimentos (2 profissionais).

8.4 Indicadores de qualidade (auditoria mensal)

Indicador	Meta
% de atendimentos com escala de dor registrada na triagem e reavaliação após analgesia	≥95% / ≥80%
% de dor moderada/intensa com 1ª analgesia em ≤30 min	≥85%
% de dor intensa tratada com opioide IV titulado (não IM) com monitorização registrada	≥90%
% de fraturas/luxações com analgesia antes do RX e bloqueio regional quando aplicável	≥90%
% de injeções IM de analgésico quando VO/IV eram possíveis (evento — reduzir)	Registrar; ↓
% de altas com opioide: duração ≤5 dias, associado a não opioide, orientação escrita	≥90%
Meperidina; codeína/tramadol em <12 anos; opioide + BZD sem monitor; analgesia negada "para não mascarar" (eventos sentinela)	0
% de sedações para procedimento com checklist (monitor, 2 profissionais, registro 5/5 min) e eventos adversos	100% / registrar
Retorno em 72 h por dor não controlada; reclamações relacionadas à dor	Registrar

9. Divergências entre fontes e itens a verificar antes da aprovação

Tema	Posição declarada
Dipirona	Não consta de diretrizes anglo-saxãs (indisponível); é base da analgesia no Brasil/SBED com segurança aceitável. Adotada como 1ª linha
Cetorolaco 15 × 30 mg	Evidência de equivalência (Motov 2017); adotado 15 mg em idoso/DRC leve e 30 mg como padrão
Cetamina em dose analgésica	AAEM 2018/ACEP: recomendada como poupadora de opioide; prática brasileira ainda limitada. Adotada com monitor
Fentanil intranasal	Padrão pediátrico internacional; exige atomizador e protocolo [VERIFICAR]
Analgesia por enfermagem na triagem	Recomendada (AAEM); exige protocolo institucional aprovado pelo diretor clínico e COREN [VERIFICAR/APROVAR]
Opioide na alta	ACEP 2020: menor dose/duração (≤3–5 dias); CDC 2022: individualizar. Adotado ≤3–5 dias
Adrenalina em bloqueio digital	Contraindicação clássica × evidência de segurança; adotado aceitável com cautela
Jejum para sedação	ACEP: não obrigatório em urgência; avaliar risco. Adotado
Diretriz SBED	Edição vigente a confirmar [VERIFICAR]
Controle de opioides (Portaria 344)	Livro de registro, receituário A/B, guarda — [VERIFICAR conformidade da farmácia do PS]

10. Referências

- Motov S, Strayer R, Hayes BD, et al. The treatment of acute pain in the emergency department: a white paper position statement prepared for the American Academy of Emergency Medicine. *J Emerg Med* 2018;54(5):731-736. Motov S, et al. Comparison of intravenous ketorolac at three single-dose regimens for treating acute pain in the ED. *Ann Emerg Med* 2017;70:177-184.
- American College of Emergency Physicians. Clinical policy: critical issues related to opioids in adult patients presenting to the emergency department. *Ann Emerg Med* 2020;76(3):e13-e39. Godwin SA, Burton JH, Gerardo CJ, et al. Clinical policy: procedural sedation and analgesia in the emergency department. *Ann Emerg Med* 2014;63(2):247-258. Green SM, et al. Clinical practice guideline for emergency department ketamine dissociative sedation: 2011 update. *Ann Emerg Med* 2011;57:449-461.
- Sociedade Brasileira para o Estudo da Dor (SBED). Diretrizes e recomendações para o tratamento da dor aguda (edição vigente) [VERIFICAR]. Brasil. Ministério da Saúde. PCDT Dor crônica (Portaria SAS/MS nº 1.083/2012). ANVISA. Portaria SVS/MS nº 344/1998 (substâncias sujeitas a controle especial).
- Chou R, Gordon DB, de Leon-Casasola OA, et al. Management of postoperative pain: a clinical practice guideline from the American Pain Society. *J Pain* 2016;17(2):131-157. Manterola C, et al. Analgesia in patients with acute abdominal pain. *Cochrane* 2011;(1):CD005660. Dowell D, et al. CDC clinical practice guideline for prescribing opioids for pain — 2022. *MMWR Recomm Rep* 2022;71(3):1-95.
- World Health Organization. Guidelines on the management of chronic pain in children. Geneva, 2020. WHO guidelines for the pharmacological and radiotherapeutic management of cancer pain in adults and adolescents. Geneva, 2018. Academia Nacional de Cuidados Paliativos. Manual de cuidados paliativos. 3ª ed. 2023.
- Velasco IT, et al. (eds.). *Medicina de Emergência: abordagem prática — HC-FMUSP*. Manole, edição vigente — capítulos de analgesia e sedação (página não conferida).

Felipe Ribeiro Toledo — Médico — CRM-SP 216.986

Responsável técnico pela elaboração